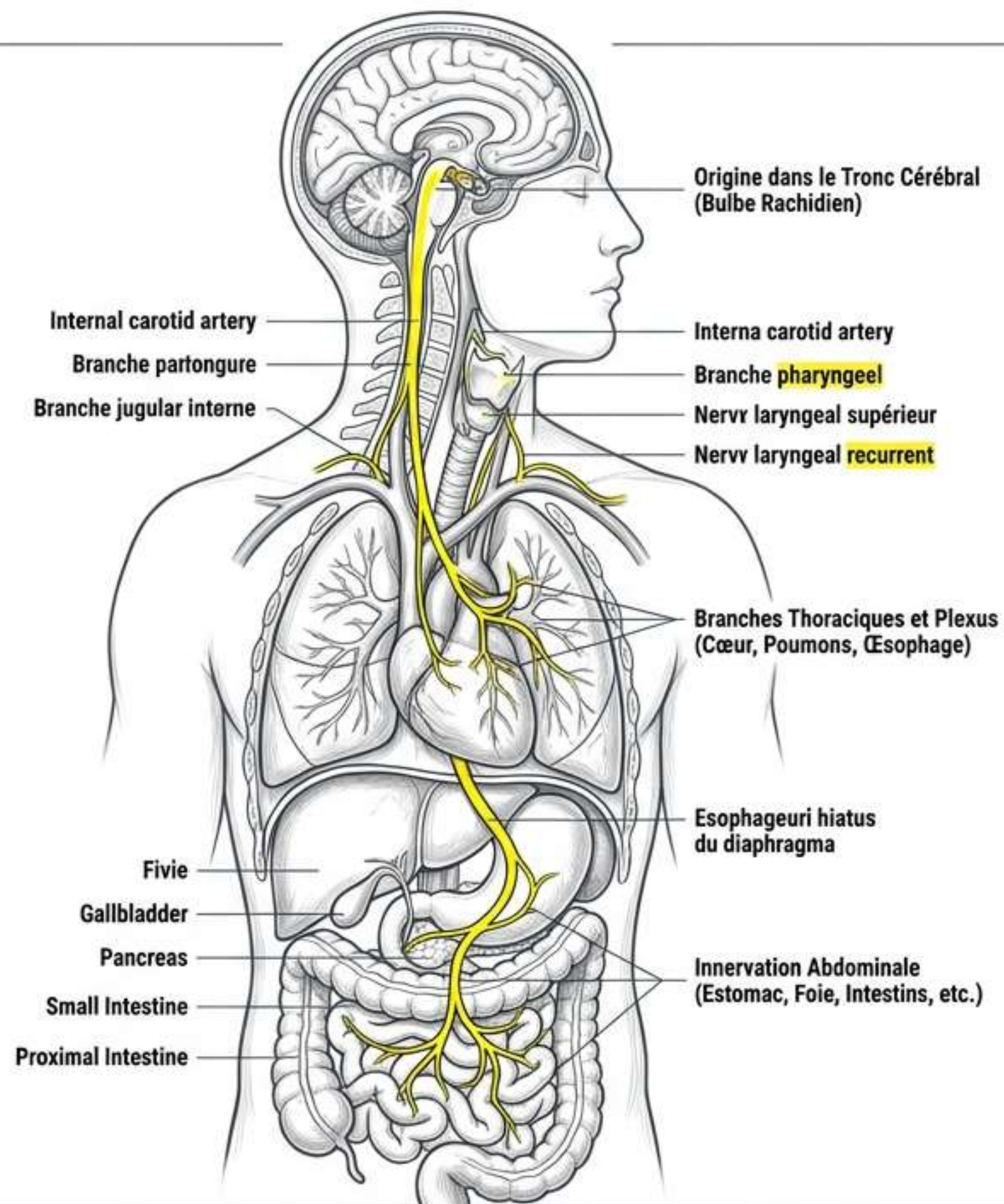


Le Nerf Vague (X)

Guide d'Étude Anatomique Complet & Atlas Clinique

Synthèse intégrale à haut rendement — Origines, Trajets, Fonctions et Corrélations Diagnostiques.



LE NERF VAGUE (X): ITINÉRAIRE ET ANATOMIE CLINIQUE



I

I. Introduction au Nerf Vague (X)

Définition, origine réelle, apparente et rôle global du système nerveux autonome parasympathique.

II

II. Anatomie Descriptive : Origines et Terminaisons

Noyaux d'origine au niveau du tronc cérébral (noyau ambigu, noyau dorsal) et terminaisons dans les plexus viscéraux thoraciques et abdominaux.



III

III. Rapports anatomiques : Base : Rapports interaction du crâne à l'Abdomen

Trajet et origines et jugular foramen.

III. Rapports Anatomiques : Base du crâne à l'Abdomen

Trajet et rapports clés dans la fosse postérieure, l'espace rétrostylien, la région cervicale, le médiastin et l'abdomen.

IV

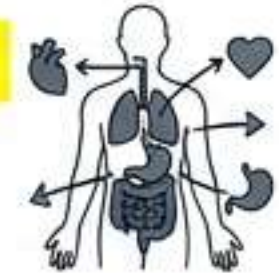
IV. Branches Collatérales

Principales branches : Nerf laryngé supérieur, Nerf laryngé récurrent (inférieur), rameaux pharyngiens, cardiaques, œsophagiens et gastriques.

V

VI. Anatomie Clinique : Atteintes et Paralysies

Innervation motrice, sensitive et sensorielle du pharynx, larynx, organes thoraciques (cœur, poumons) et viscères abdominaux.



V. Fonctions et Territoires d'Innervation

Innervation motrice, sensitive et sensorielle du pharynx, larynx, organes thoraciques (cœur, poumons) et viscères abdominaux.

VI

VI. Anatomie Clinique : Atteintes et Paralysies

Signes d'atteinte: Dysphonie, dysphagie, régurgitation nasale, bradycardie, troubles digestifs. Syndrome de Claude Bernard-Horner.

VII

VII. Références Bibliographiques

Liste des ouvrages et ressources académiques de référence pour l'étude du nerf vague (X).



VIII



VIII. Carte Mentale Synthétique Globale

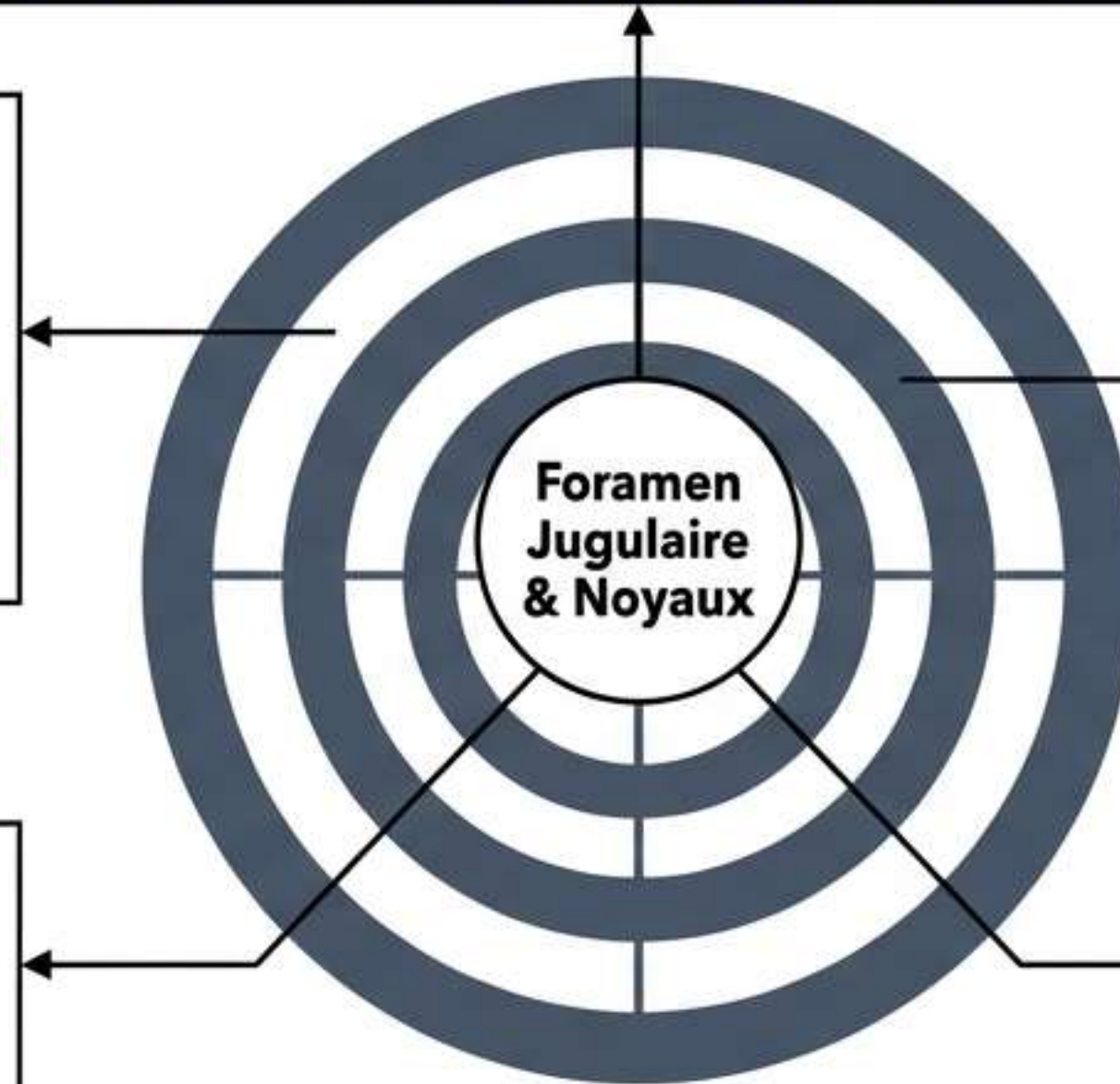
Synthèse visuelle complète des points clés du nerf vague pour une révision rapide et une rétention maximale.

ANALYSE DES MODÈLES D'EXAMEN : NERF VAGUE (X)

Sujets les plus répétés (Cibles principales) : La nature mixte des contingents (3 noyaux d'origine), les noms spécifiques des ganglions (Jugulaire vs Plexiforme), et le passage par le foramen jugulaire.

Pièges potentiels (Traps) :
Confondre l'origine du contingent végétatif (Noyau dorsal) avec le moteur (Noyau ambigu).
Inversion des rapports antérieurs/postérieurs entre le X droit et le X gauche au niveau de l'œsophage.

Nombres fréquemment testés :
Xème nerf crânien, 3 contingents, 2 ganglions, 6 étapes de trajet intra et extra-crânien.



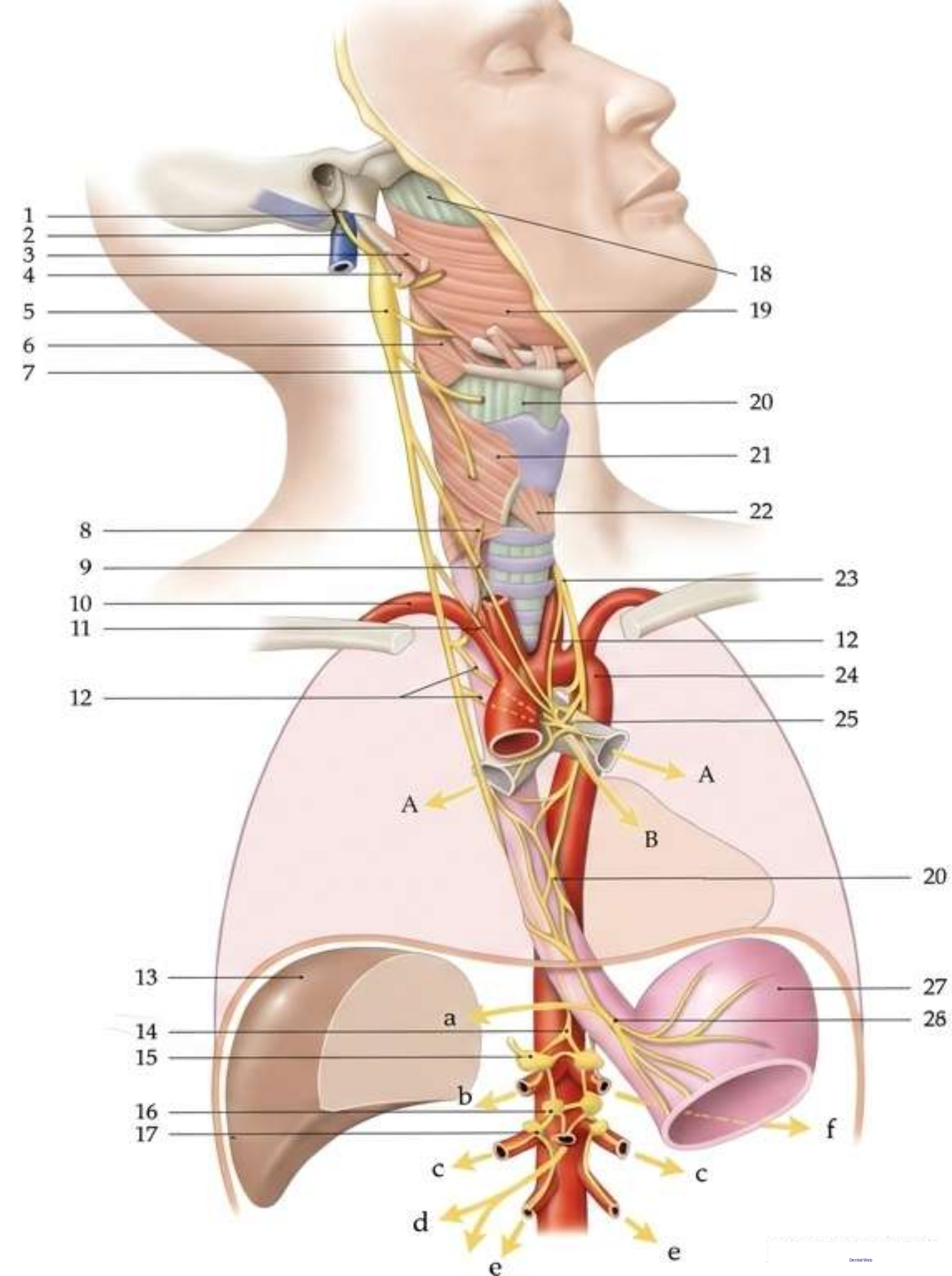
Zones rarement examinées : Les branches collatérales cervicales mineures (ex: nerf du sinus carotidien).

Indice de confiance de prédiction :
92% (Basé sur les asymétries topographiques classiques et les signes cliniques pathognomoniques).

Légende Visuelle Strict : Surlignage Jaune = Contenu exact d'examen passé. Surlignage Vert = Prédiction à haut risque.

I - Introduction au Nerf Vague (X)

- **Définition** : Le nerf vague ou pneumogastrique est le Xème nerf crânien.
- **Nature** : C'est un nerf mixte (sensitivomoteur), somatique et viscéral.
- **Étendue du territoire** : Le territoire s'étend de la tête à l'abdomen.
- **Composante Végétative** : Il est riche en fibres parasympathiques. (Appartient en grande partie au système végétatif [Predicted - Fundamental concept for dysautonomia integration]).



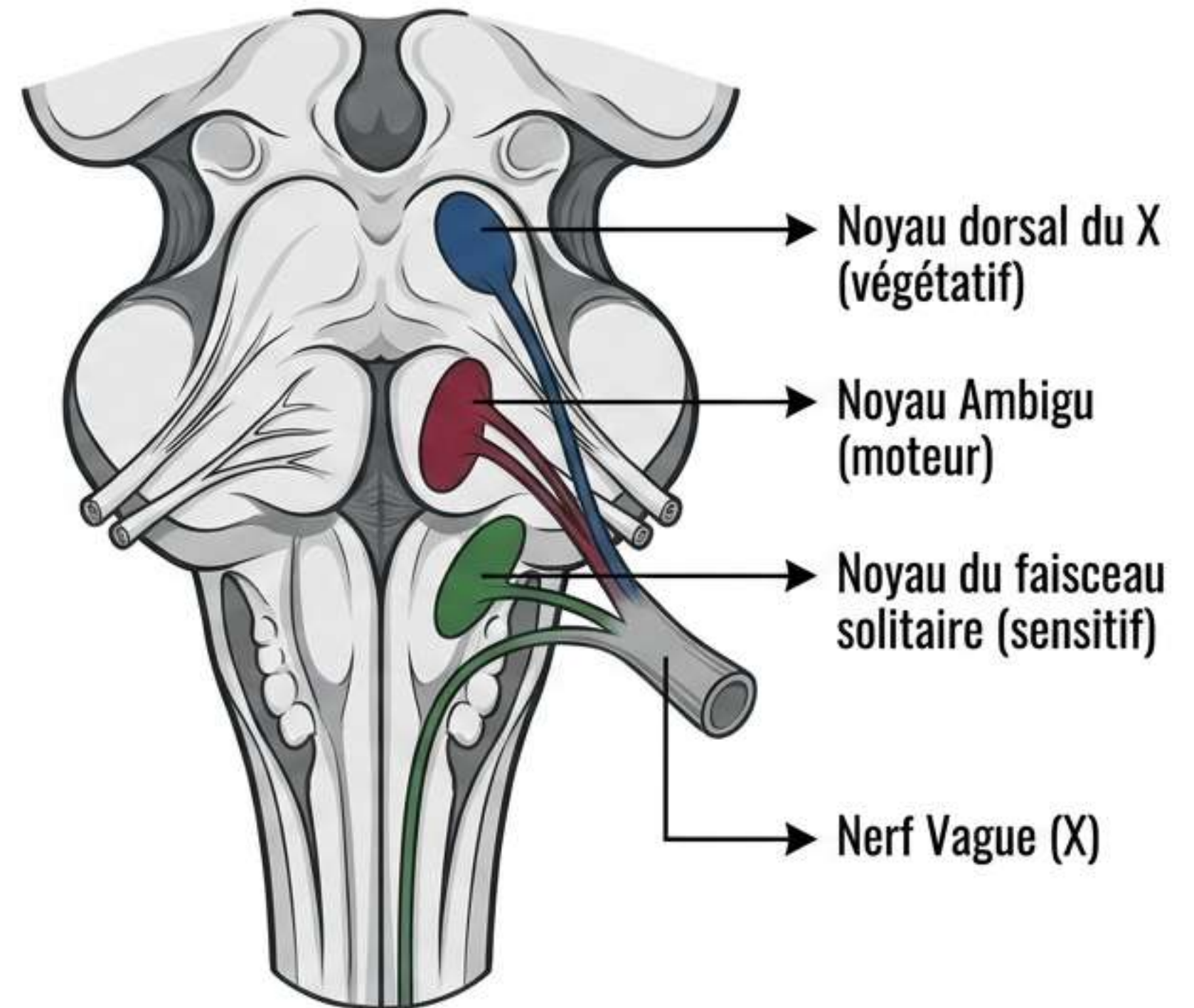
II - Anatomie Descriptive : Origine et Noyaux

A - Origine (Noyaux du tronc cérébral) :

Il présente trois contingents provenant du noyau ambigu, noyau dorsal et le faisceau solitaire. [Ref: Q14 (2024 2°EMD)]

Ventilation fonctionnelle :

- 1 - Noyau dorsal du X (contingent végétatif).
- 2 - Noyau Ambigu (contingent moteur).
- 3 - Noyau du faisceau solitaire (contingent sensitif).



II - Anatomie Descriptive : Le Trajet Global

B - Trajet (Les 6 Étapes Successives) :



Étape 1 : Fosse crânienne postérieure (Trajet Intra-crânien).



Étape 2 : Trou déchiré postérieur (Foramen jugulaire).



Étape 3 : Espace latéro-pharyngien.



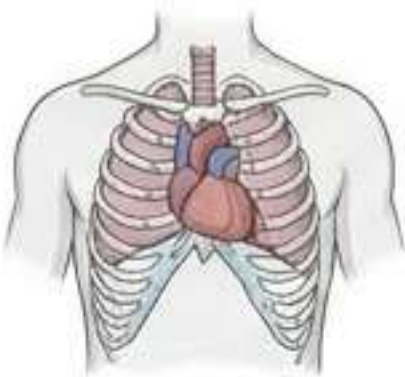
Étape 4 : Orifice supérieur du thorax.



Étape 5 : Thorax.



Étape 6 : Hiatus œsophagien du diaphragme.



III - Rapports Anatomiques : Base du Crâne et Foramen Jugulaire

1 - Dans l'étage postérieur de la base du crâne :

Le nerf se dirige latéralement et horizontalement vers le foramen jugulaire.

2 - Dans le foramen jugulaire (Trou déchiré postérieur) :

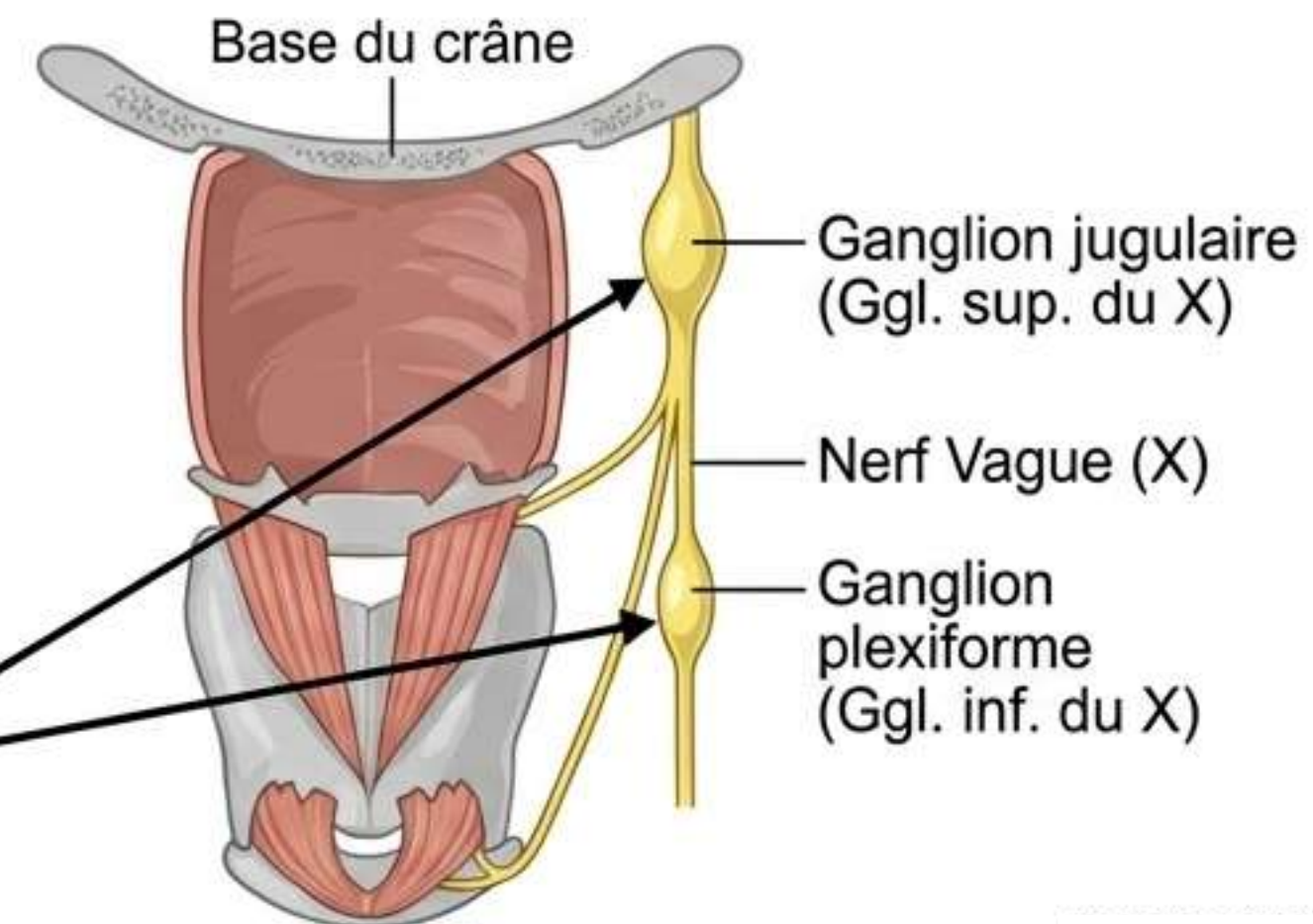
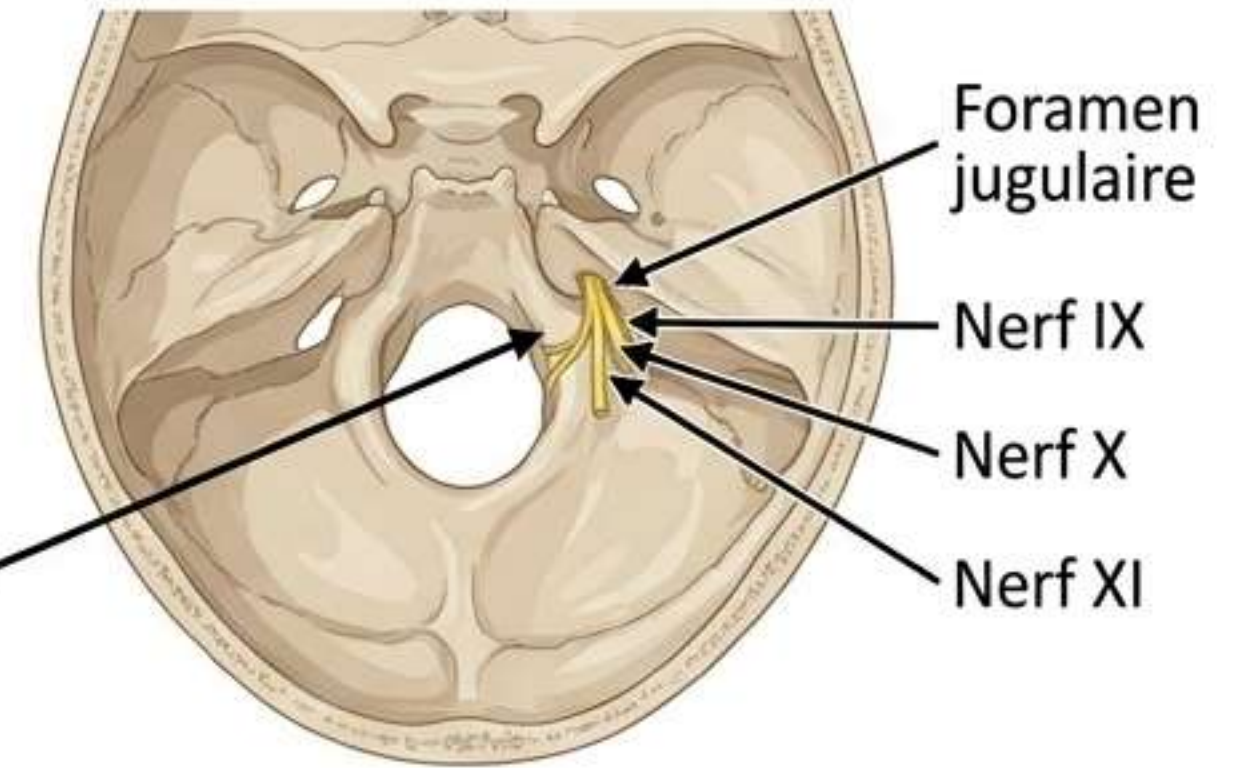
Sort de la base du crâne par le foramen jugulaire. [Ref: Q14 (2024 2°EMD)]

Il est accompagné des nerfs IX et XI et de l'artère méningée postérieure.

Il présente le ganglion supérieur du vague (ganglion jugulaire).

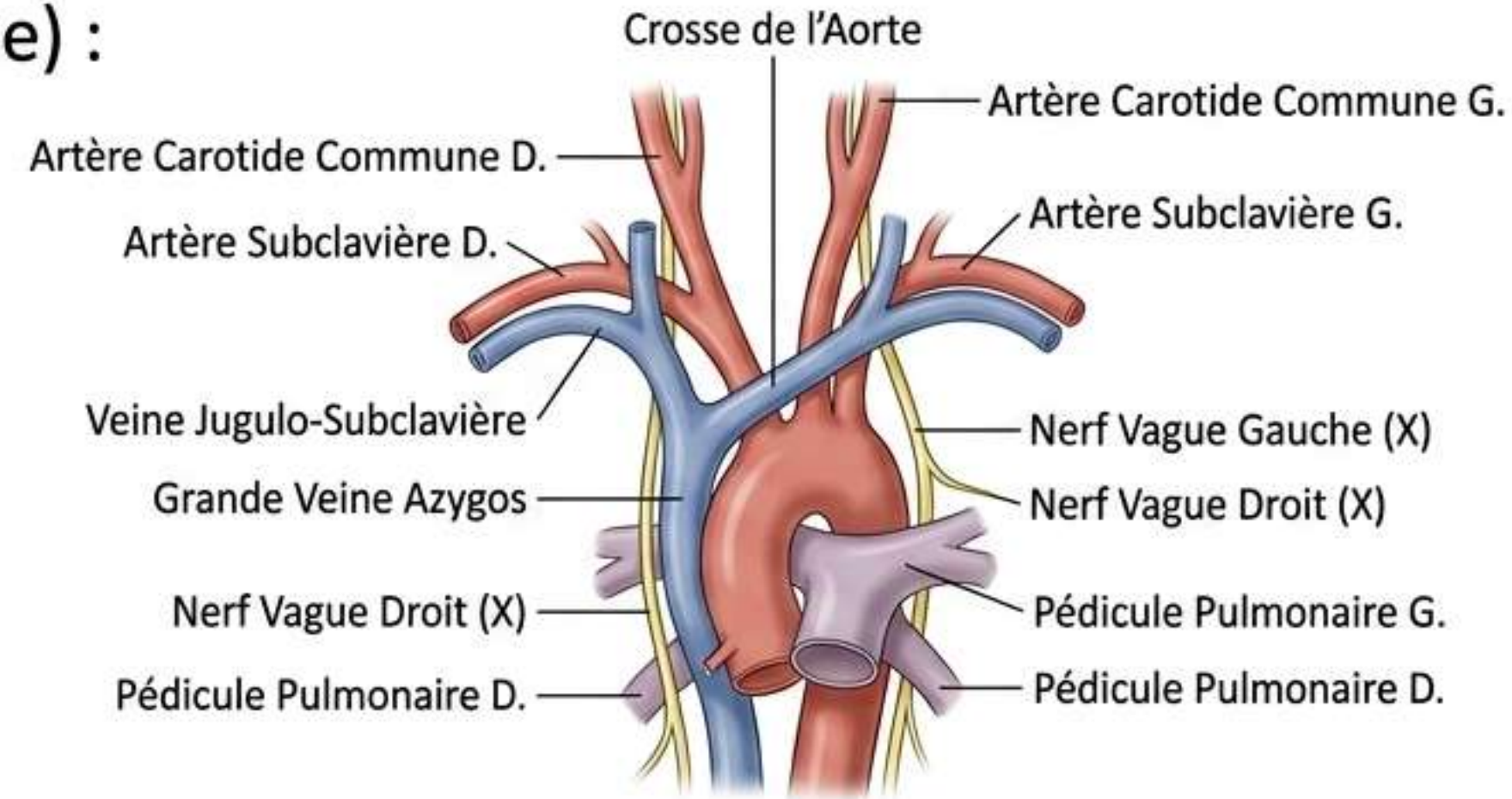
3 - À la sortie du foramen jugulaire (Espace latéro-pharyngien) :

Son ganglion inférieur est appelé ganglion plexiforme (le supérieur est le ganglion jugulaire). [Ref: Q14 (2024 2°EMD)]



III - Rapports Anatomiques : Région Cervico-Thoracique

4 – Asymétrie Topographique (Cervico-Thoracique) :



Nerf Vague Gauche (X Gauche) :

- Chemine le long de la face externe de l'artère carotide commune.
- Chemine sur la face antéro-externe de la crosse de l'aorte.
- Passe derrière le pédicule pulmonaire gauche.
- Dans le médiastin postérieur : passe en avant de l'œsophage. [Predicted - Classic orientation trap]

Nerf Vague Droit (X Droit) :

- Chemine entre l'artère subclavière et le confluent veineux jugulo-subclavier.
- Descend en dedans de la crosse de la grande veine azygos.
- (Pédicule pulmonaire droit implicite, plexus pulmonaire commun).
- Dans le médiastin postérieur : passe en arrière de l'œsophage. [Predicted - Classic orientation trap]

Plexus Communs : Derrière les pédicules pulmonaires, les 02 nerfs donnent le plexus pulmonaire. Dans le médiastin postérieur, le X donne les plexus œsophagiens.

III & II - Rapports et Terminaisons : Abdomen

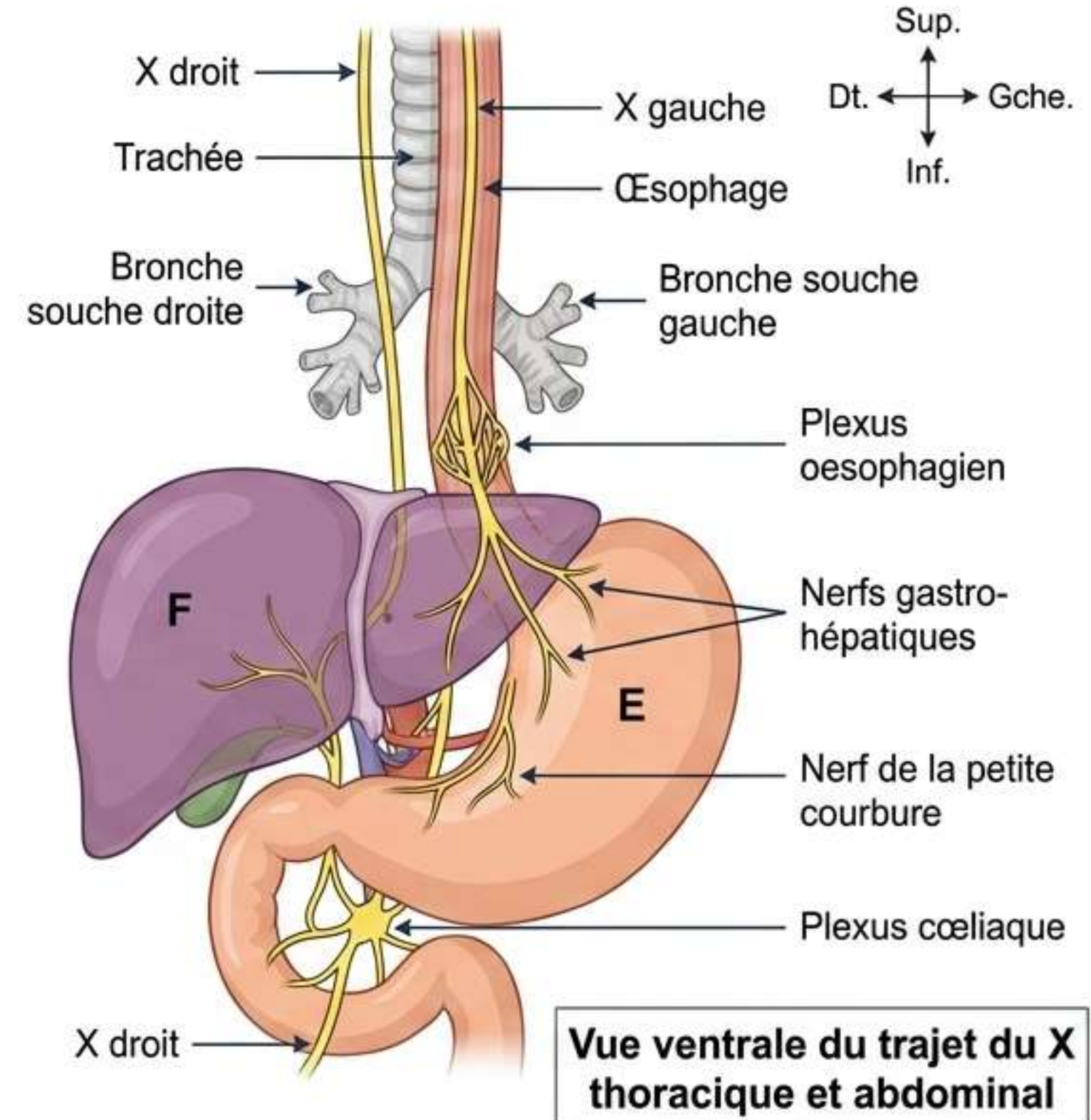
5 - Dans le hiatus œsophagien :

- Le **X gauche** est sur la face ventrale de l'œsophage.
- Le **X droit** est sur la face dorsale de l'œsophage.

6 - Dans la cavité abdominale (Terminaisons) :

- **X Gauche** : Reste sur la face ventrale de l'œsophage. Se divise en rameaux terminaux : gastriques et hépatiques.
- **X Droit** : Descend en arrière de l'œsophage. Se termine dans le plexus coeliaque (solaire).

Extensions : Le nerf vague fournit plusieurs ramifications qui vont aux plexus mésentériques supérieur et inférieur.



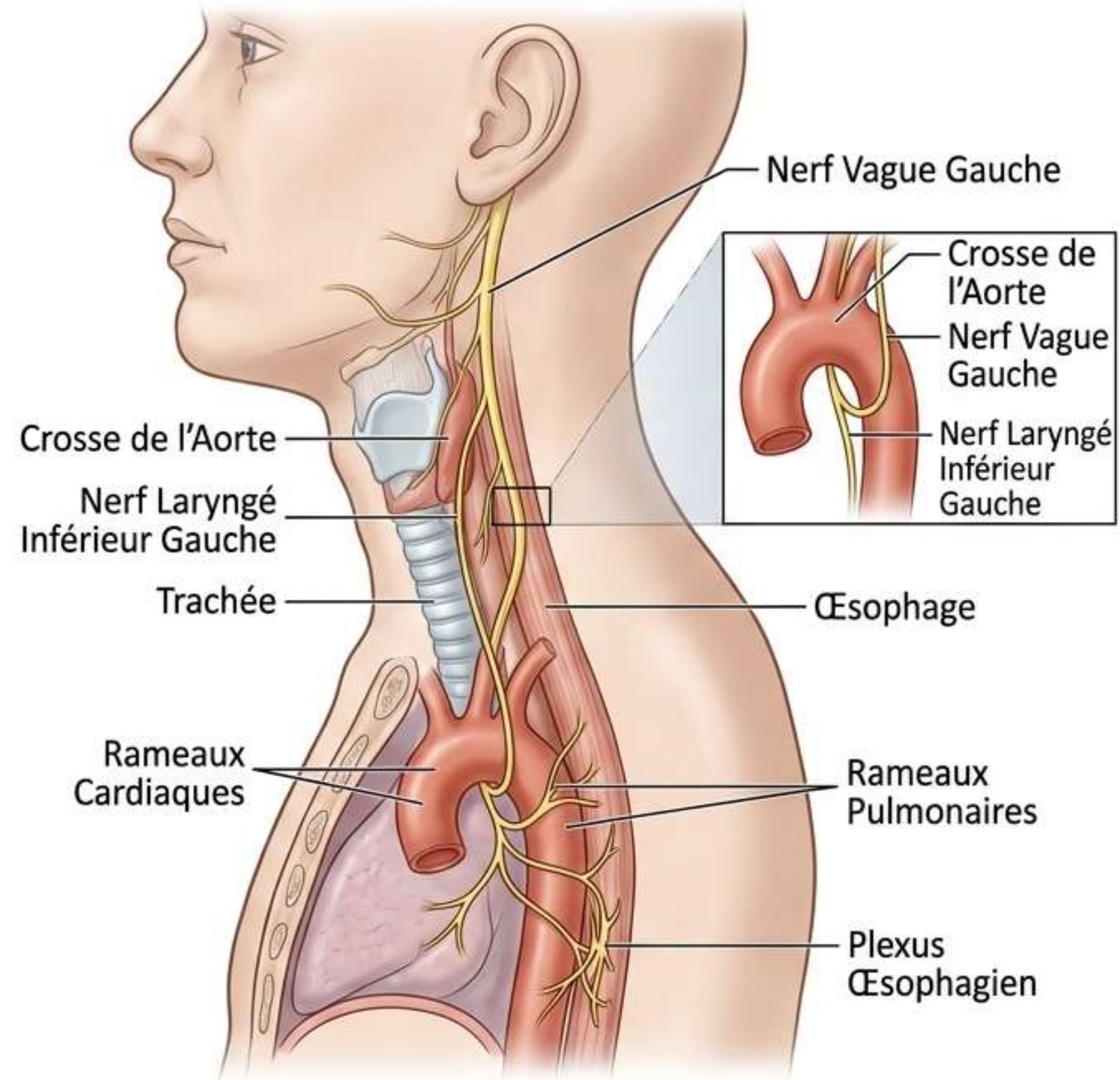
IV - Branches Collatérales (Cervicales et Thoraciques)

A - Collatérales cervicales :

- Il donne des rameaux **méningé** et **auriculaire** dès la base du crâne. [Ref: Q14 (2024 2°EMD)]
- Des rameaux : **méningé, auriculaire, pharyngiens.**
- Le **nerf du sinus carotidien.**

B - Collatérales thoraciques :

- **Le nerf laryngé inférieur (récurrent) gauche** : Naît à gauche de la **crosse de l'aorte**, il la contourne et monte dans l'**angle dièdre trachéo-œsophagien**. (Trajet asymétrique à haut rendement clinique. [Predicted])
- Les rameaux cardiaques thoraciques.
- Les rameaux **pulmonaires.**
- Les **rameaux œsophagiens.**



VI - Fonctions et Territoires : Motricité et Sensibilité

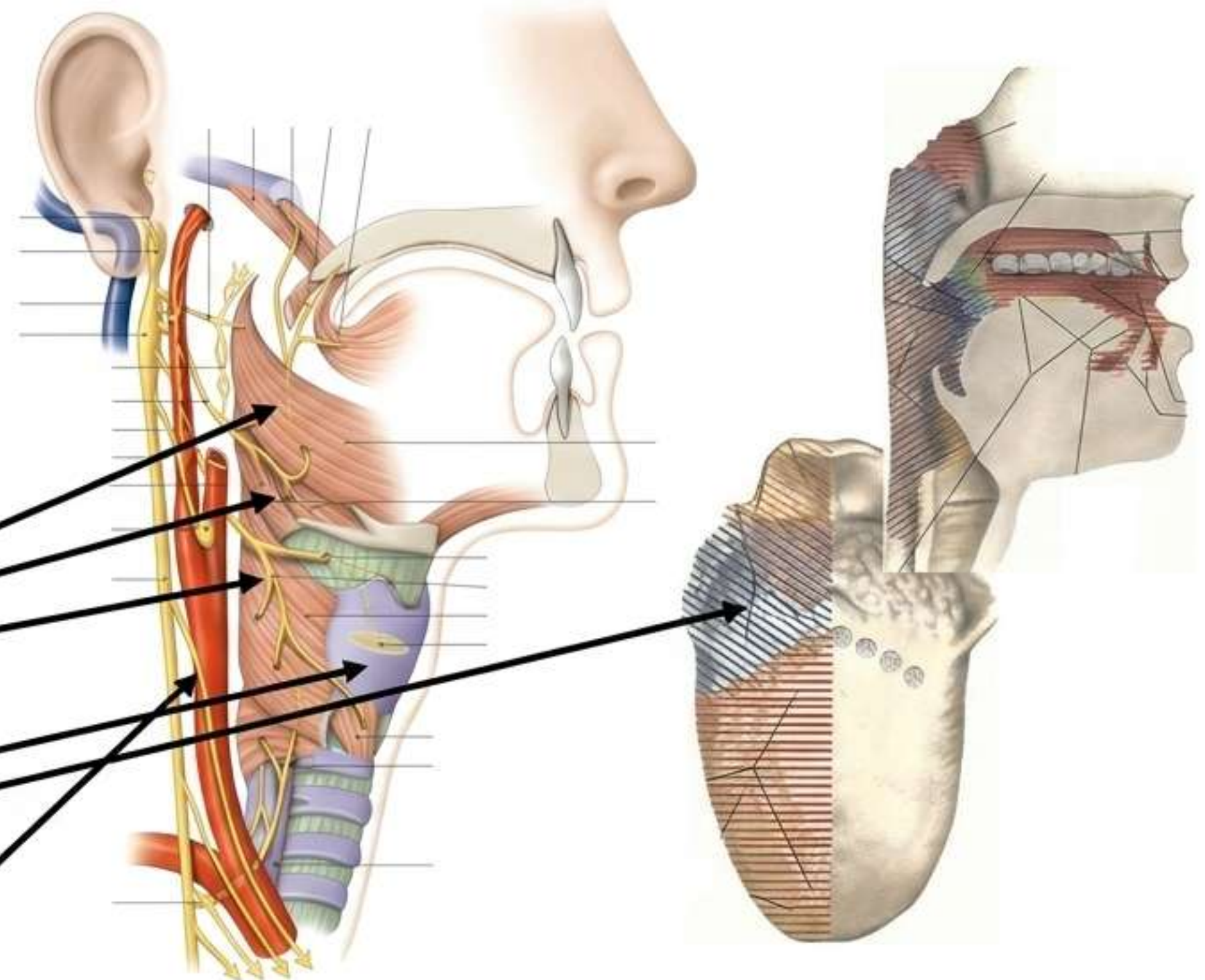
Le nerf X assure 03 fonctions principales :

01 - Une fonction motrice :

- Innerve les muscles du pharynx et du voile du palais : Rôle dans la **Déglutition** (temps pharyngien).
- Innerve les muscles du larynx : Rôle dans la **Phonation**.

02 - Une fonction sensitive : Véhicule la sensibilité de :

- Muqueuse du **pharynx** et du larynx.
- **Épiglotte**.
- **Langue** (Spécifiquement la zone située derrière le V lingual [Predicted - Classic sensory mapping trap]).
- **Zone** cutanée rétro-auriculaire et conduit auditif externe.

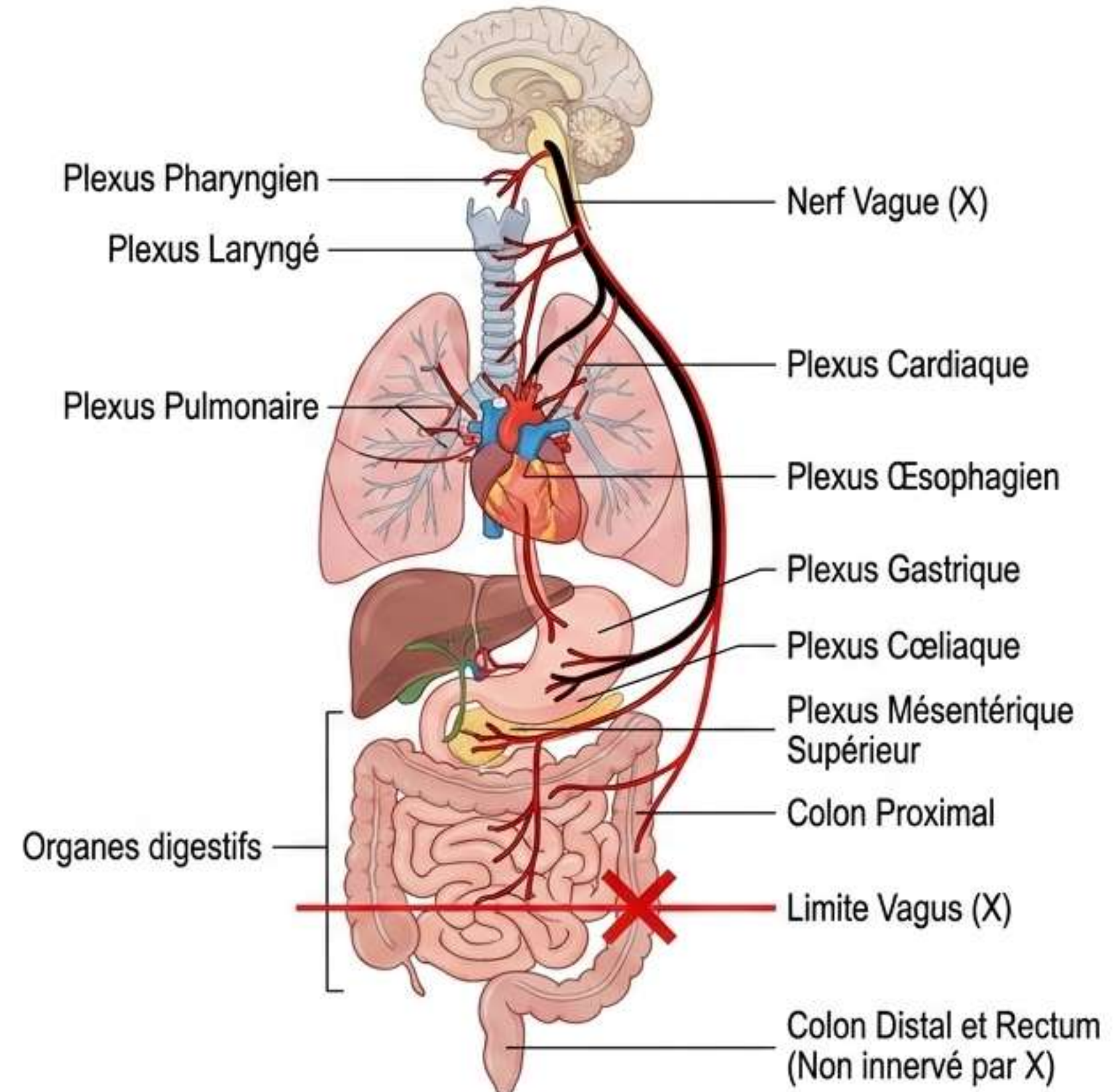


VI - Fonctions et Territoires : Système Végétatif

03 - Une fonction végétative :

Contrôle la motricité et la sensibilité des viscères thoraciques et abdominaux :

- Organes respiratoires.
- Cœur et Gros vaisseaux.
- Organes digestifs (Exception stricte : Ne contrôle ni le colon gauche, ni le rectum. [Predicted - Anatomical boundary trap]).



VII - Anatomie Clinique : Atteintes et Paralysies

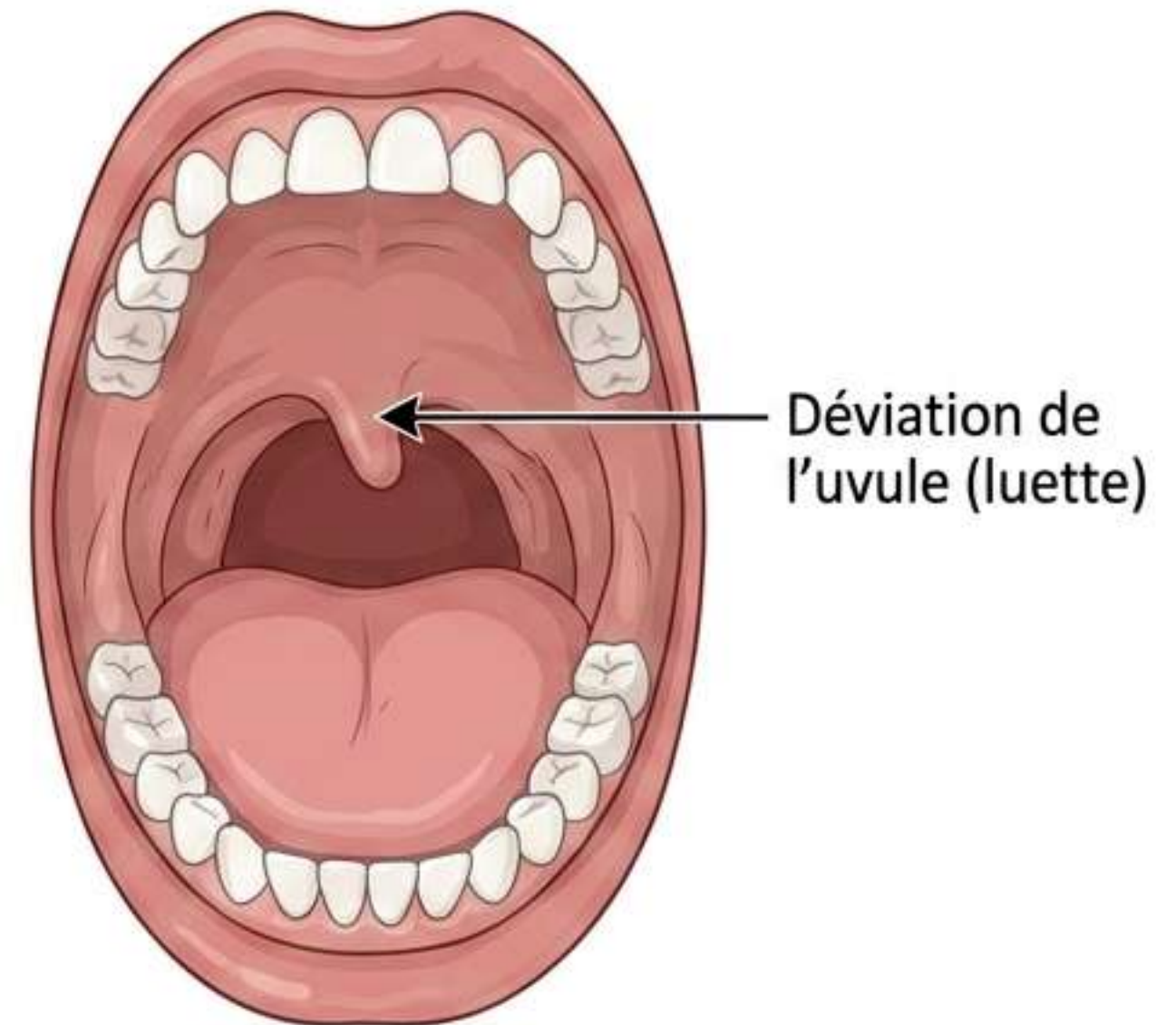
1 - Atteinte du nerf vague :

Paralysie Bilatérale (Atteinte Sévère) :

- **Dysphagie** : Trouble majeur de la déglutition.
- **Dysphonie** : Voix étouffée ou rauque (atteinte laryngée bilatérale).

Paralysie Unilatérale :

- **Signe du rideau** : Déviation de l'uvule (luette) du côté sain. [Predicted - Pathognommic visual sign]
- **Modification vocale** : Voix aigüe.



Références Bibliographiques du Cours

Sources Pédagogiques Officielles (Dr RETIA.F) :

1. Anatomie topographique SNC « BOUCHET »
2. Atlas d'anatomie « NETTER »
3. Anatomie clinique « PIERRE KAMINA »
4. Neuroanatomie clinique « André GOUAZÉ »
5. Anatomie humaine tome IV « H.ROUVIERE »
6. Le système nerveux central « G.LAZORTHES »

